

CAPÍTULO 5.4

Estenosis Carotídea

PERFIL EUNACOM 1.02.1.019

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

Introducción a la Estenosis Carotídea

La **estenosis carotídea** es el estrechamiento de las arterias carótidas, generalmente secundario a la formación de una placa de ateroma (aterosclerosis). Su importancia clínica radica en que es una de las principales causas de eventos isquémicos cerebrales, ya sea por hipoflujo distal o, más frecuentemente, por la embolización de fragmentos de la placa hacia la vasculatura intracraneal. (ver Figura 5.4)

Presentación Clínica

En la gran mayoría de los casos, la estenosis carotídea es **absolutamente asintomática**.

- **Hallazgo incidental:** Es muy común detectarla durante una ecografía de cuello solicitada por otras razones, como el estudio de patología de tiroides o masas cervicales.
- **Soplo cervical:** En el examen físico, puede auscultarse un soplo a nivel de la bifurcación carotídea. Es un signo importante de sospecha, especialmente en pacientes con factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia).
- **Eventos isquémicos:** Cuando deja de ser asintomática, se manifiesta como:
 - - **Accidente Isquémico Transitorio (AIT):** Déficit neurológico focal que revierte totalmente en menos de 24 horas.
 - - **Accidente Cerebrovascular (ACV) Isquémico:** Déficit neurológico persistente con evidencia de infarto cerebral.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: La placa de ateroma reduce el lumen arterial. El riesgo de síntomas no solo depende del grado de estrechez (porcentaje de estenosis), sino también de la estabilidad de la placa. Una placa "inestable" o ulcerada tiene mayor riesgo de desprender trombos hacia el cerebro.

Diagnóstico y Clasificación

El estudio inicial de elección es el **Eco-Doppler carotídeo**, que permite evaluar tanto la anatomía de la arteria como la velocidad del flujo sanguíneo para estimar el grado de obstrucción.

La clasificación se divide fundamentalmente según el porcentaje de obstrucción del lumen:

TABLA 5.4.1: GRADO DE ESTENOSIS VS CATEGORÍA

GRADO DE ESTENOSIS	CATEGORÍA	CONDUCTA GENERAL
< 50%	Estenosis no significativa	Manejo médico y seguimiento.
50% - 69%	Estenosis significativa moderada	Evaluación de síntomas para decidir cirugía.
70% - 99%	Estenosis significativa severa	Alta probabilidad de indicación quirúrgica.
100%	Oclusión total	No se opera (el riesgo de recanalización es mayor al beneficio).

Manejo Médico

Todo paciente con diagnóstico de estenosis carotídea, independientemente de si requiere cirugía o no, debe recibir un

tratamiento médico óptimo para estabilizar la placa y reducir el riesgo cardiovascular global:

- **Estatinas:** Piedra angular del tratamiento para estabilizar la placa de ateroma (independiente de los niveles de colesterol).
- **Antiagregantes plaquetarios:** Generalmente **Aspirina** (o Clopidogrel si hay contraindicación).
- **Control de factores de riesgo:** Manejo estricto de la **Hipertensión arterial esencial**, cese del hábito tabáquico y control de la **Diabetes mellitus tipo 2**.

Tratamiento Quirúrgico: Endarterectomía Carotídea

La **endarterectomía** consiste en la apertura quirúrgica de la arteria carótida para remover la placa de ateroma. Es el tratamiento definitivo para reducir el riesgo de un ACV futuro en pacientes seleccionados.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla de Oro para el EUNACOM (Indicaciones de Cirugía): Para decidir la cirugía (endarterectomía), debemos cruzar dos datos: **¿Tiene síntomas? y ¿Cuál es el % de estenosis?**

- **Paciente ASINTOMÁTICO:** Solo se opera si la estenosis es **≥ 70%**.
- **Paciente SINTOMÁTICO (AIT o ACV previo):** Se opera si la estenosis es **≥ 50%**.
-

Escenarios Clínicos de Ejemplo

- **Caso 1:** Paciente con un **Accidente Cerebrovascular** isquémico. El Doppler muestra una estenosis carotídea del **20%**.
 - - **Conducta:** La estenosis **no es significativa** (< 50%). No se puede atribuir el ACV a esta estenosis. Se debe continuar el estudio de fuente embólica (ej. buscar una **Fibrilación auricular crónica**).
- **Caso 2:** Paciente con un ACV isquémico y Doppler que muestra estenosis del **60%**.
 - - **Conducta:** Es una estenosis **significativa en paciente sintomático**. Tiene indicación de endarterectomía carotídea.
- **Caso 3:** Paciente que se realiza ecografía de tiroides y se encuentra estenosis carotídea del **75%**, sin antecedentes de síntomas neurológicos.
 - - **Conducta:** Es una estenosis **≥ 70% en paciente asintomático**. Tiene indicación de endarterectomía para prevención primaria de ACV.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡Cuidado! Si el paciente presenta un ACV de tipo **hemorrágico**, la estenosis carotídea no es la causa y la endarterectomía está contraindicada en la fase aguda, ya que el problema no es obstructivo sino de ruptura vascular.

Resumen de Perlas EUNACOM

- El examen inicial siempre es el **Eco-Doppler**.
- La estenosis se considera "significativa" desde el **50%**.
- Si el paciente tiene **síntomas**, el umbral para operar baja al **50%**.
- Si el paciente **no tiene síntomas**, el umbral para operar sube al **70%**.
- El tratamiento médico (estatinas + aspirina) se inicia en **todos** los pacientes con estenosis significativa.
- Si hay oclusión del 100%, ya no hay flujo que pueda arrastrar émbolos de forma significativa o el daño ya está hecho; por lo tanto, generalmente **no se opera**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

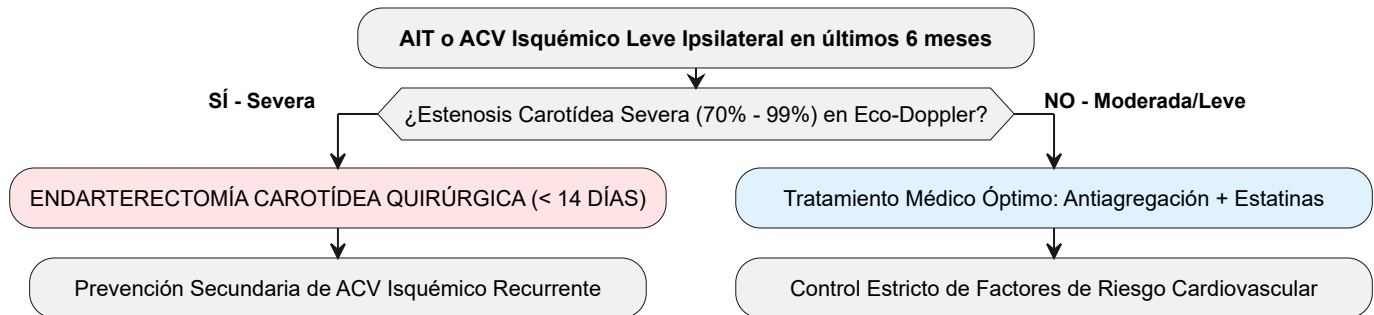
"Hombre de 71 años presenta amaurosis fugaz izquierda de 10 min seguida de paresia de mano derecha recuperada totalmente. Eco-Doppler carotídeo revela estenosis del 82% en carótida interna izquierda."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

La Estenosis Carotídea Sintomática (post-AIT o ACV leve ipsilateral en últimos 6 meses) con estenosis severa (70-99%) requiere Endarterectomía Carotídea quirúrgica precoz (idealmente <14 días del síntoma) asociada a tratamiento médico óptimo para prevenir ACV isquémico recurrente.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La estenosis carotídea causa el 15-20% de los ACV isquémicos
- La amaurosis fugax (ceguera monocular transitoria) es un AIT carotídeo clásico
- El eco-Doppler carotídeo es el examen de primera línea
- Tratamiento médico óptimo para todos: aspirina, estatinas, control PA, cese tabáquico
- Endarterectomía indicada en estenosis sintomática 70-99% (beneficio claro)
- La endarterectomía debe realizarse dentro de las 2 semanas del evento
- Stenting carotídeo es alternativa en alto riesgo quirúrgico

FIGURA 5.4: ALGORITMO DE ESTENOSIS CAROTÍDEA SINTOMÁTICA (AIT / ACV)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ESTENOSIS CAROTÍDEA)**PREGUNTA 1**

Estenosis Carotídea

- A)** Solo tratamiento médico con aspirina y estatinas
- B)** Endarterectomía carotídea dentro de 2 semanas más tratamiento médico
- C)** Anticoagulación con warfarina de por vida
- D)** RMN cerebral y controlar en 6 meses
- E)** Doble antiagregación indefinida

PREGUNTA 2

Estenosis Carotídea

- A)** Angiografía convencional
- B)** Angio-TAC de vasos de cuello
- C)** Eco-Doppler carotídeo
- D)** RMN cerebral
- E)** Arteriografía cerebral

PREGUNTA 3

Estenosis Carotídea

- A)** Endarterectomía carotídea preventiva
- B)** Stenting carotídeo
- C)** Tratamiento médico óptimo y seguimiento con eco-Doppler
- D)** Anticoagulación con TACO
- E)** No requiere tratamiento ni seguimiento

RESUMEN EJECUTIVO: ESTENOSIS CAROTÍDEA

La estenosis carotídea es el estrechamiento de las arterias carótidas, principalmente por aterosclerosis, en la bifurcación carotídea. Es responsable del 15-20% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Los factores de riesgo son los mismos de la aterosclerosis: tabaquismo, HTA, diabetes, dislipidemia y edad avanzada. El diagnóstico se realiza con eco-Doppler carotídeo como examen de screening y primera línea. La angio-TAC o angio-RMN confirman el grado de estenosis cuando se planifica intervención. La estenosis puede ser sintomática (ACV o AIT ipsilateral en los últimos 6 meses) o asintomática. El grado de estenosis se mide según criterios NASCET. El tratamiento médico óptimo es la base para todos los pacientes: antiagregación, estatinas de alta intensidad, control de HTA y cese tabáquico. La endarterectomía carotídea está indicada en estenosis sintomática del 70-99% (beneficio claro), y se considera en sintomática del 50-69% según factores individuales. En asintomáticos con estenosis mayor al 70%, la indicación es más controvertida y depende del riesgo quirúrgico. El stenting carotídeo es alternativa cuando hay alto riesgo quirúrgico.